

1.

Un homme de 43 ans se présente aux urgences avec des douleurs lombaires et irradiation au membre inférieur gauche et faiblesse du pied.

A l'examen vous constatez une faiblesse du releveur du pied et de l'hallux et de l'éversion du pied et une hypoesthésie superficielle du dos du pied. Le Lasègue est positif.

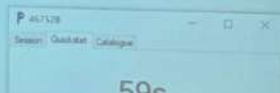
Quel est la racine concernée ?

A) L3

B) L4

C) L5

D) S1



2.

Un homme de 71 ans présente de façon brutale une aphasie.

Le scanner (natif) aux urgences puis l'IRM cérébrale (T2*) à distance sont ci-dessous.



Quel est le diagnostic le plus probable:

- A. Un hématome sur hypertension.
- B. Une tumeur maligne.
- C. Un méningiome.
- D. Un hématome sur amyloïdose cérébrale.

P 407525

Séance Quizcat Catalogue

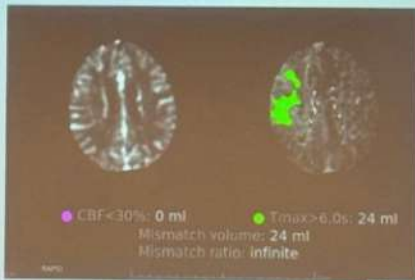
Tag: Question: Qu

Id Tag: 30x

Un patient de 40 ans présente depuis quatre
jours de violentes douleurs d'une

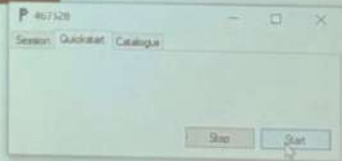
3.
Patiente de 78 ans, connue pour une HTA, qui à 8h en prenant son petit déjeuner présente une faiblesse hémicorps G. Le NIHSS est à 4.

Le scanner cérébral à 10 h exclut une hémorragie et voici ci-dessous la cartographie de perfusion



En l'absence de contre indication, devez vous faire une lyse IV et pourquoi:

- A. Non, car il n'y a pas de lésion ischémique.
- B. Oui, car il y a une zone de pénombre.
- C. Oui, car la lésion ischémique est constituée.
- D. Non, car le déficit n'est pas assez sévère.



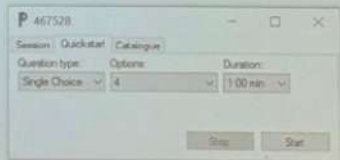
4.

Une patiente de 37 ans, connue pour une infection VIH, sous trithérapie bien conduite, avirémique au dernier contrôle il y a un mois, vous consulte au cabinet car elle présente des troubles sensitifs et moteurs des membres inférieurs, d'apparition progressive sur 2 jours, remontant par la suite aux membres supérieurs. Elle rapporte également des lombalgies inhabituelles et des douleurs musculaires.

À l'examen clinique, on retrouve une force globalement diminuée à MRC M4/5 aux membres inférieurs, une hypoesthésie avec dysesthésie distales des quatre membres ainsi qu'une perte de tous les réflexes ostéotendineux.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Myélopathie cervicale
- B. Poly radiculo neuropathie
- C. Polyneuropathie
- D. Syndrome de la queue de cheval



5.

Une patiente de 36 ans, consulte aux urgences pour l'apparition progressive, sur environ 4 semaines, d'une ptose de la paupière de l'œil gauche, initialement présente seulement le soir puis devenue constante depuis 3 jours, accompagnée d'une diplopie intermittente. Elle rapporte également une sensation de fatigue généralisée, un changement de tonalité de sa voix et une dyspnée à l'effort, notamment en montant les escaliers. Il s'agit du premier épisode du genre. Elle a eu une infection urinaire à E Coli traitée par ciprofloxacine juste avant le début des symptômes.

À l'examen neurologique, on retrouve une ptose palpébrale de l'œil gauche, et une minime parésie bilatérale du regard vers le haut. L'abduction de l'œil gauche est également limitée, avec diplopie dans le regard vers la droite. On note une voix légèrement hypophone. La force est préservée aux quatre membres. La sensibilité est normale. Les réflexes ostéotendineux sont normaux.

Devant ce tableau clinique, laquelle de ces propositions est vraie ?

- A. La patiente présente une atteinte isolée du nerf III gauche.
- B. Le caractère actuellement constant de la ptose palpébrale permet d'écarter un diagnostic de myasthénie.
- C. Comme bilan initial, un dosage des anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine (anti-RACH) et un ENMG avec stimulation répétitive sont indiqués.
- D. Un scanner cérébral en urgence est nécessaire afin d'écarter un AVC aigu.

6.

Un homme de 78 ans consulte son médecin de famille pour des chutes à répétition depuis 6 mois. Il n'y a pas de perte de connaissance. L'anamnèse auprès du patient révèle un ralentissement et une instabilité à la marche. L'épouse relate un léger déclin cognitif et des troubles sphinctériens pour lesquels une consultation urologique est prévue. Le patient est traité pour une HTA mal équilibrée et est en excès pondéral. Il boit 3 verres standards d'alcool par jour.

A l'examen, le MMSE est à 24/30. Pas de signes de latéralisation, roue dentée à la manœuvre de Froment au membre supérieur droit, marche ralentie, instable avec un polygone élargi et un ballant préservé.

Vous demandez une IRM cérébrale qui montre:



Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Une hydrocéphalie à pression normale.
- B. Une sclérose en plaques.
- C. Une démence vasculaire.
- D. Un AVC ischémique pariétal G



7.

Vous vous entretenez avec une patiente de 30 ans atteinte d'une sclérose en plaques. L'IRM cérébrale et médullaire met en évidence une dizaine de lésions supratentorielles (juxta-corticales et périventriculaires) ainsi qu'une lésion du cervelet et de la moelle cervicale en C4-C5. Sur la dernière IRM, la lésion cervicale prenait le contraste. La patiente présente un syndrome pyramidal déficitaire des membres inférieurs, une ataxie à la marche et des difficultés de concentration.

Vous la voyez ce jour car lors de la dernière visite clinique, elle se montrait opposée à débiter un traitement immunosuppresseur. Vous aviez alors recommandé un traitement à haute efficacité.

Lequel de ces arguments pour l'introduction d'un traitement immunosuppresseur est juste ?

- A. On pourrait débiter une corticothérapie per os chronique (par exemple prednisone 1 mg/kg/j) à la place des immunosuppresseurs classiques, car les corticostéroïdes ont un effet bénéfique préventif sur la diminution du risque de récurrence de poussée.
- B. Avec un immunosuppresseur reconnu comme efficace dans la prévention des poussées dans la SEP, vous bénéficiez également d'un effet neuroprotecteur et neuro réparateur direct.
- C. Les immunosuppresseurs utilisés dans la SEP ont tous un effet démontré sur la diminution du risque de poussée et la diminution du risque de nouvelle lésion à l'IRM.
- D. Un traitement de vitamine D à haute dose serait une bonne alternative de substitution à la place des immunosuppresseurs, car son efficacité a été clairement démontrée sur la progression de la maladie dans des études de phases 3 randomisées-contrôlées.

P 467528

Session Quizlet Catalogue

8.

Monsieur G 66 ans est traité depuis quelques mois par flunarizine et metoclopramide pour des vertiges et nausées dans le cadre d'une maladie de Ménière .

Il vous consulte en raison d'un tremblement de repos et d'attitude aux 2 mains apparu depuis quelques semaines

A l'examen clinique il existe une rigidité et une bradykinésie bilatérale et une marche à petits pas. Il n'a pas de plaintes cognitives ni d'incontinence.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Syndrome parkinsonien médicamenteux
- B. Maladie de parkinson
- C. Hydrocéphalie à pression normale
- D. Tremblement essentiel

9.

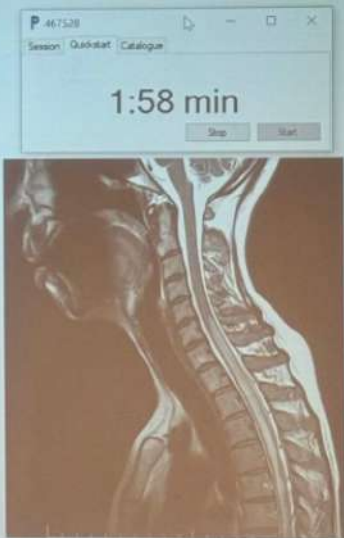
Une jeune patiente d'origine asiatique de 30 ans se présente aux urgences avec une paraparésie évoluant à son maximal en 12 heures, associée à une incontinence urinaire. Les antécédents révèlent une névrite optique droite sévère, partiellement résistante aux glucocorticoïdes, investiguée il y a 2 ans sans piste claire.

Voici l'IRM médullaire pratiquée aux urgences :

La ponction lombaire révèle 74 globules blancs/microL.

Quel examen est le plus approprié:

- A. Un CT thoracique et une enzyme de conversion de l'angiotensine.
- B. Une serologie HIV
- C. Les Ac anti-Aquaporin-4.
- D. Les Facteurs antinucléaires et anti DNA natif..

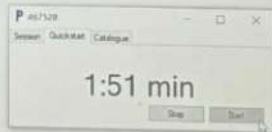


10.

Une employée de bureau de 26 ans consulte son médecin traitant en raison de céphalées qui depuis son adolescence se manifestent une à deux fois par mois pendant 1 à 2 jours et ne répondent que très partiellement à la prise de 1 g de paracétamol. Elles peuvent se manifester sur la moitié gauche ou droite du crâne avec une douleur intense de caractère pulsatile. Elle se plaint aussi d'une sensibilité à la lumière ce qui avec la douleur rend son travail à l'ordinateur très pénible. Elle est en bonne santé sans surcharge pondérale. Elle ne prend pas d'autres médicaments ou drogues et ne fume pas. L'examen clinique général et neurologique est dans les normes.

La démarche adaptée est :

- A. De demander une imagerie cérébrale dans les meilleurs délais.
- B. D'effectuer un bilan sanguin de routine.
- C. De demander une imagerie cérébrale en urgence.
- D. De proposer un autre traitement médicamenteux aigu des douleurs.



11.

Un homme de 75 ans se présente à votre consultation en se plaignant de pertes de mémoire depuis 1 à 2 ans. L'IRM cérébrale montre une atrophie cérébrale globale modérée et une atrophie hippocampique modérée.

L'examen neuropsychologique révèle un déficit de la mémoire prospective, une diminution de la vitesse de traitement et des difficultés à trouver les mots.

L'examen du LCR montre une diminution de l'AB42 et une élévation de la tau et de la p-tau.

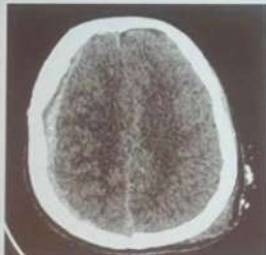
Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Démence à corps de Lewy
- B. La maladie d'Alzheimer
- C. Démence fronto-temporale
- D. Amnésie globale transitoire

12.

Un homme de 50 ans est amené aux urgences car trouvé inconscient par son épouse à l'entrée de leur maison

Voici deux coupes de son scanner cerebral.



Quel est le diagnostic juste ?

- A un hématome épidural avec engagement sous falcien
- B un hématome sous dural avec engagement trans tentorien
- C un AVC avec important effet de masse
- D un engorgement amygdalien sur hypertension intracrânienne

P 467528

Session: Quizz

Question type:

Single Choice

Partie 2

Le phlebo CT confirme une thrombose veineuse cérébrale et révèle la lésion ci-contre

Quel est le traitement adéquat ?

- A aspirine
- B thrombolyse
- C anticoagulation
- D Facteur VII a recombinant



13.

Question séquence

Partie 1

Vous voyez à l'unité des urgences ambulatoire une jeune patiente de 25 ans pour des céphalées.

Elle est connue pour des migraines épisodiques sans aura, qu'elle traite occasionnellement par paracétamol ou ibuprofène. Elle ne prend pas de traitement hormis sa contraception orale. Elle ne consomme pas de substance mais fume 10 cigarettes par jour depuis 10ans.

Les céphalées ont débuté il y a 5 jours, constantes, oppressives, holocrâniennes, en progression depuis hier soir, aggravée le matin au réveil et en position allongée. Elles cèdent partiellement au traitement antalgique habituel. Elle rapporte une discrète photo et phonophobie ainsi qu'un flou visuel persistant depuis hier. Elle a vomit à deux reprises et se plaint de nausées depuis 48h.

A l'examen clinique elle est afebrile, en état général conservé, pas de raideur de nuque. Le status neurologique est globalement dans la norme

Que lui proposez vous en premier lieu?

- A) IRM cérébrale en ambulatoire
- B) Phlébo-CT en urgence
- C) Ponction lombaire en urgence
- D) Consultation ophtalmologique en ambulatoire

P 467528

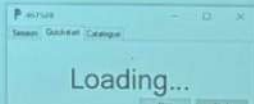
Session	Quichstat	Catalogue
Question type:	Options:	Duration:
Single Choice	4	2:00 min

14.

Un homme de 34 ans, en bonne santé, a subi un malaise avec perte de connaissance alors qu'il venait de se lever brusquement pour aller uriner. Sa rapporte que le patient a eu des mouvements convulsifs des 4 membres qui ont duré environ 15 secondes. Le patient a repris connaissance environ une minute plus tard et a tout de suite pu parler et marcher normalement. Il ne ressentait rien de plus. Il vous consulte en cabinet le lendemain matin.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Hypoglycémie
- B. Syncope orthostatique
- C. Crise d'épilepsie
- D. Crise psychogène non épileptique
- E. Syncope sur arythmie cardiaque



15.

Une femme de 49 ans, dépendante à l'alcool et ayant subi un bypass gastrique en raison d'une obésité 6 ans plus tôt, est adressée aux urgences par sa fille en raison de l'installation rapidement progressive sur une semaine d'un état confusionnel et de troubles de l'équilibre, dans le contexte d'une période de plusieurs semaines de diminution des apports alimentaires en raison de nausées et de l'augmentation de la consommation d'alcool.

L'examen physique révèle une ataxie à la marche. On note également un nystagmus multi-directionnel et une diplopie. Sur le plan neurocomportemental, on observe un état confusionnel chez une patiente peu collaborante.

La glycémie capillaire au tri est à 4.1 mmol/l. La tension artérielle à 150/90 mmHg.

La chimie sanguine démontre une hyponatrémie à 130 mmol/l et une hypokaliémie à 3.4 mmol/l.

La prise en charge la plus urgente consiste à :

- A. Administrer une perfusion intraveineuse de Glucose et d'électrolytes iso-osmolaire ;
- B. Administrer une perfusion intraveineuse de 300 mg de thiamine 3x/j ;
- C. Administrer un traitement de benzodiazépines oral ;
- D. Effectuer un Scanner cérébral avec administration de produit de contraste ;

P 467528

Session	Question	Catégorie
Question type	Options	Duration
Single Choice	4	2.00 min

Next Skip

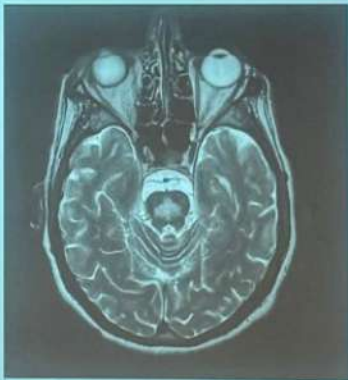
16.

Un homme de 65 ans, diabétique et hypertendu, présente une gastro entérite non fébrile mais très sévère lors de ses vacances. Présentant une déshydratation sévère, il est d'abord traité sur place puis en raison de l'apparition d'une tetraparésie, il est rapatrié en Suisse aux urgences.

A l'examen vous retenez une tetraparésie et une ataxie.
Voici une coupe T2 de son IRM cérébrale.

Quel est le diagnostic les plus probable?

- A. Un AVC ischémique paramedian pontique.
- B. Un syndrome de Guillain Barré.
- C. Un syndrome de Miller Fisher.
- D. Une myélinolyse centro pontique.



P 467528

Session Quickstart Catalogue

17.

Une étudiante de 21 ans vous consulte quelques jours après avoir été conduite aux urgences en raison de la survenue d'une crise épileptique tonico-clonique généralisée. Il s'agissait du premier épisode de ce genre qu'elle subissait. Lors de l'évaluation aux urgences, une IRM cérébrale s'est avérée sans particularité, et un EEG a mis en évidence des bouffées de pointes-ondes généralisées. Un traitement anticonvulsivant a été mis en route. A la reprise de l'anamnèse, la patiente vous informe que depuis quelques mois, elle subit de brèves secousses musculaires dans l'heure qui suit le réveil, qui peuvent parfois lui faire renverser son café.

De quel type d'épilepsie souffre cette patiente ?

- A. Épilepsie temporale médiale
- B. Épilepsie-absences de l'enfant
- C. Épilepsie myoclonique juvénile
- D. Épilepsie focale structurale
- E. On ne peut pas affirmer un diagnostic d'épilepsie



18.

Monsieur P, âgé de 77 ans, connu pour une HTA, vient aux urgences pour des douleurs thoraciques en ceinture et une faiblesse de membres inférieurs

Les constantes sont dans la normes. L'ECG et les troponines sont normales.

A l'examen neurologique, les membres supérieurs semblent sans particularité mais vous reprenez une parésie et une hypoesthésie tacto-algique des membres inférieurs. La sensibilité profonde est conservée. Les réflexes rotuliens et achilléens sont vifs et le réflexe cutané plantaire est en extension des deux côtés.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Un AVC du territoire de l'ACA.
- B. Une myélopathie thoracique ischémique.
- C. Un syndrome de la queue de cheval.
- D. Un canal cervical étroit.

P 467528

Session Quickstart Catalogue

Question type: Options:

Single Choice 4